

Introduzione al modulo di Salute Mentale — Sintesi

Salute Mentale · Sessione 01

Salute, benessere e normalità: tre parole che sembrano semplici, ma non lo sono per niente. Questa lezione smonta le certezze e costruisce basi solide per tutto il modulo.

Struttura del modulo

- Tre tappe: **clinica, mondo, corpo**
- Attraversate da: spazio, tempo, identità, incontro
- L'operatore sociale come ponte tra discipline specialistiche, non specialista di una sola

Salute: le 7 condizioni di Boorse (1977)

Nessuna delle sette regge da sola: - **Valore** — non universale: contesti in cui la malattia è "preferibile" esistono - **Trattamento medico** — la medicina colonizza ambiti non patologici - **Norma statistica** — fuori dalla media ≠ malato - **Sofferenza** — malattie asintomatiche e dolori fisiologici esistono - **Disabilità** — fasi di "non abilità" sono normali nella vita (neonato, sonno) - **Adattamento** — l'uomo adatta anche l'ambiente a sé, non solo il contrario - **Omeostasi** — la vita si fonda sulla rottura e riconquista dell'equilibrio, non sull'equilibrio statico

Disease, illness, sickness

- **Disease** → dimensione biomedica (misurabile)
- **Illness** → vissuto soggettivo della persona
- **Sickness** → riconoscimento/stigma sociale

- Le tre dimensioni possono non coincidere — e lo stigma sociale peggiora l'andamento della malattia

Benessere: le 6 dimensioni di Ryff

- **Autonomia** — autodeterminarsi senza dipendere dagli altri per ogni scelta
- **Controllo ambientale** — valorizzare le risorse disponibili
- **Relazioni positive** — relazioni calde, fiduciose, reciproche
- **Autoaccettazione** — consapevolezza di qualità e limiti
- **Percezione di crescita** — sentire di evolvere
- **Scopo nella vita** — avere mete e dare senso

Salute ≠ benessere. Si può stare bene senza essere in salute (Terzani) e male pur essendo "sani". Per l'operatore: queste dimensioni rendono il lavoro sul benessere *concreto e operativo*.

Tre tipi di normalità

- **Statistica** — nella media; fuori dalla norma porta stigma
- **Di valore** — ideale irraggiungibile → sofferenza perpetua; attenzione: anche i *nostri* ideali sugli utenti possono diventare penalizzanti
- **Personale** — rispetto a come funzionavo prima; attenzione a non idealizzare il passato, e a non considerare quella normalità come obiettivo se era proprio lei la causa del problema

Posizione del soggetto verso la malattia

Due assi: **identificazione** con la condizione × **agentività** (attivo/passivo)

- Passivo + non identificato → **delega** ("guariscimi")
- Agentivo + non identificato → **guarigione** come unico obiettivo
- Agentivo + identificato → **cura**: lavora sul benessere dentro la condizione

Passaggio chiave: dalla guarigione alla cura. *To cure ≠ to care*: la cura è sempre possibile, anche quando la guarigione non lo è.

La tragedia greca

- Dispositivo pedagogico parallelo al modulo
- 5 gruppi, 5 tragedie per estrazione
- Tappe: leggere → condividere → sintetizzare → mettere in scena (~20 min)
- Allena: ascolto di linguaggi non familiari, lavoro di équipe, sintesi, capacità di rinuncia
- Quest'anno tutte le tragedie convergono sulla violenza sulle donne nei conflitti armati — tema antico e attualissimo (Nadia Murad, Congo, Iraq)

Da ricordare: salute, benessere e normalità sono tre concetti distinti ma intrecciati. La cura è sempre possibile, anche quando la guarigione non lo è. Il contesto è fondamentale per interpretare qualsiasi comportamento.